Síntomas urinarios y hematuria

SEMIOLOGIA · Clase 33 · dolor renal, alteraciones de la micción y de dónde viene la sangre

1 · POR QUÉ LA ANAMNESIS URINARIA PESA: EL RIÑÓN AVISA TARDE

F1 **Anamnesis genitourinaria**
en tres bloques: dolor, alteraciones de la micción y características de la orina

interroga el dolor, cuyo origen es la → F2 Origen del dolor renal

importa porque detecta la

F1 **Lesión renal insidiosa**
la función se deteriora antes de dar señales urinarias directas

se anuncia con

F1 **Síntomas inespecíficos**
astenia, náuseas, vómitos, anorexia, anemia, irritabilidad neuromuscular

aunque no parezcan renales

Ante síntomas vagos se investiga la orina y la función renal

2 · DOLOR RENAL: LA CÁPSULA SE ESTIRA

F2 **Origen del dolor renal**
el parénquima no duele: duele la distensión de la cápsula renal

pregunta también por el → F3 Cólico renal

si se distiende despacio da el

F2 **Dolor lumbar renal**
sordo, profundo, de instalación gradual; empeora de pie y al final del día; sin náuseas ni vómitos

hay que separarlo del

aparece en

F2 **Contextos**
síndrome nefrítico, nefritis intersticial, pielonefritis aguda; quiste poliquístico roto o infectado

Dolor lumbar extrarrenal (frecuente)
lumbalgia muscular, espondiloartrosis, hernia discal

por eso

modifica el

El patrón del dolor orienta la causa y dirige el examen físico (lámina 34)

3 · CÓLICO RENAL: LA VÍA SE DILATA DE GOLPE

F3 **Cólico renal**
dilatación súbita de la pelvis o del uréter con espasmo del músculo liso, casi siempre por un cálculo

se irradia por el trayecto

por eso es

F3 **Dolor lancinante en oleadas**
instalación rápida; inquietud, sudoración, náuseas y vómitos; ninguna postura alivia

F3 **Irradiación**
lumbar, flanco, fosa ilíaca, ingle, hasta el testículo o los labios mayores

su trayecto orienta el → F5 Diuresis normal

puede ceder de golpe si pasa el

Si el dolor cesa de golpe, el cálculo pasó a la vejiga

4 · CUÁNTO SE ORINA: OLIGURIA, ANURIA Y POLIURIA

pregunta cuánto se orina: la → F5 **Diuresis normal**
800 a 1.800 ml/24 h (media 1.400): unos 60 ml/h y cerca de 1 ml/min (cálculo)

si cae por debajo da

además se pregunta por el

si sube por encima da

F4 **Oliguria**
menos de 400 ml/24 h (unos 20 ml/h)

F4 · F6 **Poliuria**
más de 2.000 ml/24 h

F4 **Ritmo y forma de orinar**
disuria, urgencia, polaquiuria, nicturia, incontinencia, retención; tenesmo con estranguria

se debe a

en la diabetes descompensada por

no confundir con la

si la orina no sale hay → F8 Retención urinaria

si cae aún más hay

también la causan

Causas de oliguria
hipovolemia (deshidratación, hemorragia, insuficiencia cardiaca) o lesión renal estructural

F4 **Anuria**
menos de 100 ml/24 h; casi siempre obstrucción de ambos uréteres o arterias renales

F7 **Diuresis osmótica**
diabetes descompensada: la glucosa arrastra agua; en la obesa deshidratada que orina mucho se busca glucosuria

F6 **Otras causas de poliuria**
diabetes insípida, hipercalcemia, hipopotasemia, diuréticos, exceso de líquidos

F4 · F6 **Polaquiuria**
micciones repetidas sin subir el volumen total: no es poliuria

se interpreta con la

se mide con la

se confirma con la

se confirma con la

se separa con la

La medición de las 24 horas separa el aumento real de volumen del aumento de frecuencia

5 · LA VEJIGA QUE NO SUELTA O ARDE Y LA URETRA QUE SECRETA

en la uretra se pregunta por la → F15 **Secreción uretral** (🛍️ literatura)
uretrorrea, piouretrorragia, hemouretrorragia, quilorragia: nombran lo que sale por el meato

no se confunde con la

F15 **Uretritis**
es la enfermedad (inflamación de la uretra), no una secreción

se almacena en la → **Vejiga**
capacidad de 350 a 450 ml; el reflejo de orinar se dispara hacia los 200 ml

pregunta por el color: si es → Orina roja

si la salida se tapa hay

si se inflama causa

F8 **Retención urinaria**
la orina se acumula y no sale; mecanismo obstructivo

Dolor vesical
suprapúbico; si se irrita el trígono se irradia a uretra y meato como deseo de orinar

en el varón mayor por

con inflamación intensa hay

F8 **Causas**
hipertrofia benigna de próstata (la más típica), cáncer de próstata, vejiga neurogénica por lesión medular

F9 **Espasmo del trígono y del cuello vesical**
ante una inflamación intensa de la vejiga

es el cuadro clásico del

frente al tenesmo es

produce el

F8 **Varón mayor de 60 años**
deja de orinar y tiene dolor en el bajo vientre: retención aguda por HBP

F9 **Tenesmo vesical**
sensación de vaciamiento insuficiente; micción lenta y dolorosa (estranguria)

se confirma con el

frente a la retención es

Se confirma con el globo vesical al examen físico (lámina 34)

F8 · F9 Retención = obstrucción de la salida (próstata); tenesmo = inflamación de la vejiga

6 · SANGRE EN LA ORINA: FALSA O VERDADERA

Orina roja
no siempre es sangre: primero se descarta la falsa hematuria

si hay sangre real es

puede ser solo la

F10 · F11 **Falsa hematuria**
orina rojiza o anaranjada que no es sangrado urinario

F10 · F11 **Hematuria**
sangre macro o microscópica en la orina; nunca debe ignorarse

se produce por

según lo que la acompaña orienta a

F10 · F11 **Qué la produce**
sangre menstrual mezclada, betarraga, rifampicina, fenazopiridina

Qué la acompaña
fiebre, escalofríos y disuria: infección; dolor cólico: litiasis; además anticoagulantes y tumor

por eso

descartada la falsa exige

Toda hematuria real exige estudio urológico completo, aunque su cantidad no mida la gravedad

7 · DE DÓNDE VIENE LA SANGRE: PRUEBA DE LOS TRES VASOS

se localiza por el → F10 · F11 **Momento de la hematuria**
en qué parte de la micción aparece la sangre y, por tanto, de qué nivel viene

si tiñe solo el comienzo

si tiñe toda la micción

si tiñe solo el final

F14 **Inicial**
solo el primer vaso rojo: uretra

F13 **Total**
los tres vasos rojos: riñón, uréter o vejiga

F12 · F13 · F14 **Terminal**
solo el último vaso rojo: cuello vesical o trígono, que sangra al exprimirse la vejiga

se comprueba con la

se comprueba con la

se comprueba con la

F10 · F13 **Prueba de los tres vasos**
la orina de una micción se reparte en tres vasos; el vaso teñido marca el nivel

ubica el origen y dirige el

El momento de la sangre ubica el origen y dirige el estudio (sedimento, imagen)

técnica · mecanismo · síntoma · desenlace · ejemplo · concepto · causa · signo · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 10a · Anamnesis y síntomas del aparato genitourinario — teoría del docente (Sotomayor 2020; Sotito 2018); 🛍️ = literatura